

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI)

Eje VI • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh
Sigla	PSQI
Autores	Buysse, D. J., Reynolds III, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J.
Año	1989
Eje	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Constructo principal	Sueño y ritmos circadianos
Población	Adultos, adultos mayores y adolescentes
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Varias adaptaciones, ej. Macías y Royuela, 1996; Jiménez-Genchi et al., 2008)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	© University of Pittsburgh; uso no comercial sujeto a solicitud/permiso; no redistribuir.
Periodo temporal de referencia	Último mes

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Sueño y ritmos circadianos. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Salud física, estilo de vida y medicina conductual
Dimensiones declaradas	7 componentes: Calidad subjetiva, Latencia, Duración, Eficiencia habitual, Alteraciones del sueño, Uso de medicación y Disfunción diurna.

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos, adultos mayores y adolescentes
Número de ítems	19 ítems (más 5 ítems que responde el compañero de cama/habitación que no se incluyen en el puntaje total)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 a 3) y preguntas abiertas de tiempo
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	5 a 10 minutos

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	7 componentes: Calidad subjetiva, Latencia, Duración, Eficiencia habitual, Alteraciones del sueño, Uso de medicación y Disfunción diurna.
Ítems	19 ítems (más 5 ítems que responde el compañero de cama/habitación que no se incluyen en el puntaje total)
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 a 3) y preguntas abiertas de tiempo
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Se calculan puntuaciones para los 7 componentes (0-3). La suma de los componentes da un puntaje global de 0 a 21. Mayor puntaje indica peor calidad de sueño.

Regla de corrección	Se calculan puntuaciones para los 7 componentes (0-3). La suma de los componentes da un puntaje global de 0 a 21. Mayor puntaje indica peor calidad de sueño.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Un puntaje > 5 indica "malos dormidores" (sensibilidad del 89.6% y especificidad del 86.5% para distinguir buenos y malos dormidores).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Excelente fiabilidad test-retest y consistencia interna aceptable. Es el Gold Standard mundial en investigación y clínica para evaluar la calidad subjetiva del sueño en el último mes.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Excelente fiabilidad test-retest y consistencia interna aceptable. Es el Gold Standard mundial en investigación y clínica para evaluar la calidad subjetiva del sueño en el último mes.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Traducciones por circuito oficial.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos, adultos mayores y adolescentes
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Sueño y ritmos circadianos en Adultos, adultos mayores y adolescentes, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Buysse, D. J., Reynolds III, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J.; 1989.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Varias adaptaciones, ej. Macías y Royuela, 1996; Jiménez-Genchi et al., 2008)
- Trazabilidad local: 1 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Sueño y ritmos circadianos
Población	Adultos, adultos mayores y adolescentes
Estructura	Catálogo: 19 ítems (más 5 ítems que responde el compañero de cama/habitación que no se incluyen en el puntaje total).; 7 componentes: Calidad subjetiva, Latencia, Duración, Eficiencia habitual, Alteraciones del sueño, Uso de medicación y Disfunción diurna.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Se calculan puntuaciones para los 7 componentes (0-3). La suma de los componentes da un puntaje global de 0 a 21. Mayor puntaje indica peor calidad de sueño.
Interpretación	Un puntaje > 5 indica "malos dormidores" (sensibilidad del 89.6% y especificidad del 86.5% para distinguir buenos y malos dormidores).
Estado de fuentes	Locales válidos: 1; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Buyse, D. J., Reynolds III, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh.

Fuente de referencia del catálogo: Múltiples bases académicas y repositorios institucionales.

<https://www.sleep.pitt.edu/research/measures-and-study-instruments>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2748771/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.